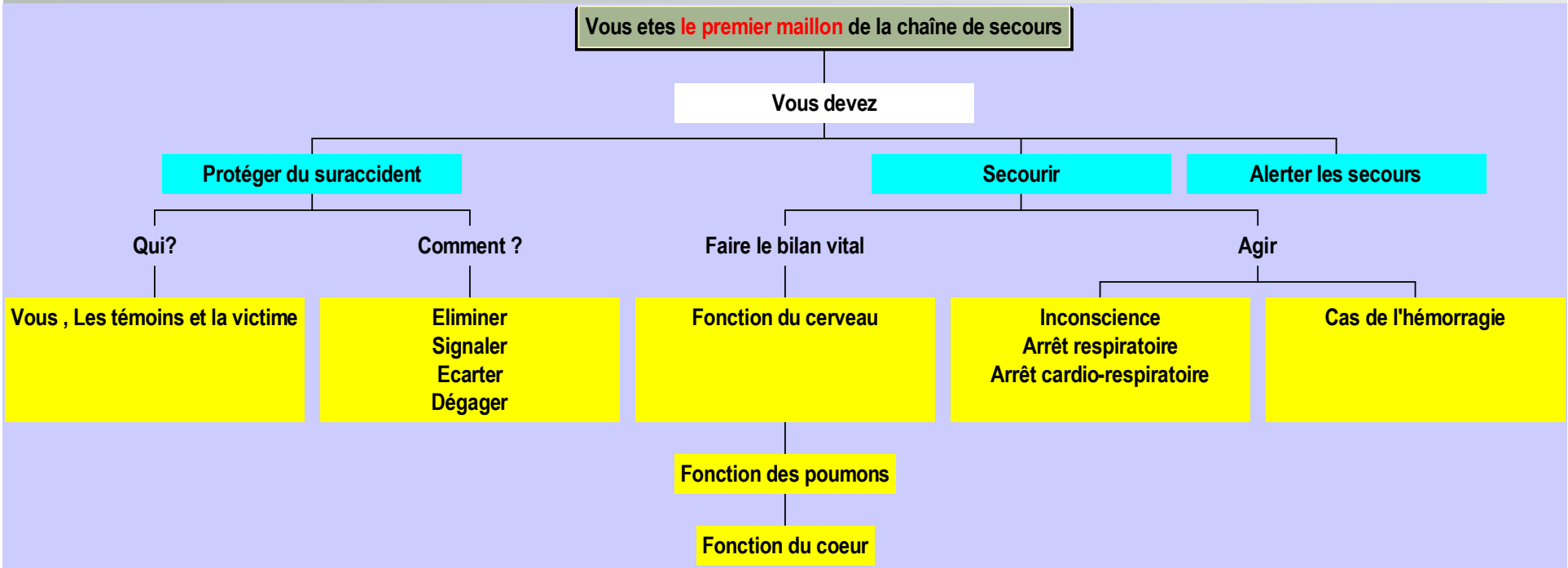
FORMATION EN SECOURISME

La Chaîne de survie

Témoin-Sauveteur - **Equipe de premier secours** - **Equipe médicale** - **Unité hospitalière**

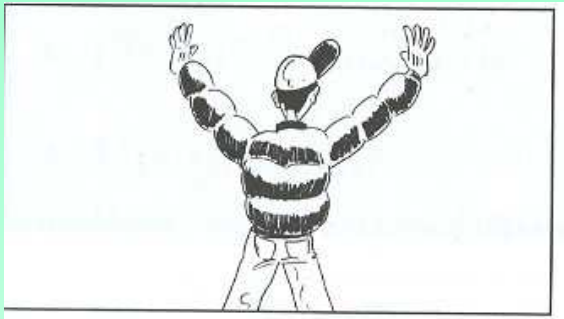
VOUS augmentez la chance de survie de la victime de + de 50% si vous agissez rapidement !


Vous etes le premier maillon de la chaîne de secours
Vous devez
Protéger du suraccident
Secourir
Alerter les secours
Qui?
Comment ?
Faire le bilan vital
Agir
Vous , Les témoins et la victime
Eliminer
Signaler
Ecarter
Dégager
Fonction du cerveau
Inconscience
Arrêt respiratoire
Arrêt cardio-respiratoire
Cas de l'hémorragie
Fonction des poumons
Fonction du coeur

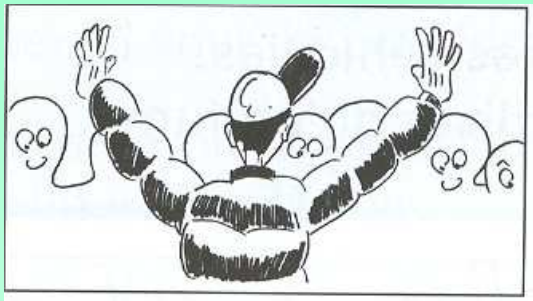
Protéger du suraccident

- **QUI?**
- **COMMENT?**

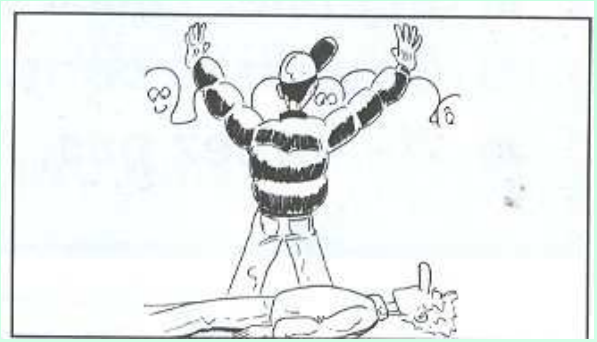
QUI?



VOUS



Les TEMOINS



La VICTIME

COMMENT?

- Eliminer toutes les sources d ’énergie
- Signaler l ’accident
- Tenir les témoins à distance
- Dégager la victime

Eliminer toutes les sources d ’énergie ayant causé l ’accident ou pouvant l ’aggraver (tjs avec prudence)

- Contact auto
- Courant électrique
- Interdire de fumer
- produits inflammables
- Courants d ’air (incendie)
- Source d ’eau (accident électrique)

Signaler l ’accident

- Feu de détresse
- Lampe
- Sirène ou klaxon
- Moyens de signalisation
- Autres

Tenir les témoins à distance

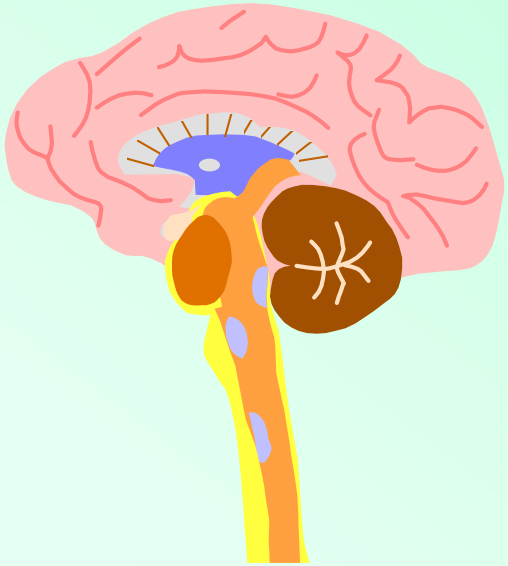
Dégager la victime si nécessaire

Secourir

- **Bilan vital**
- **Agir**

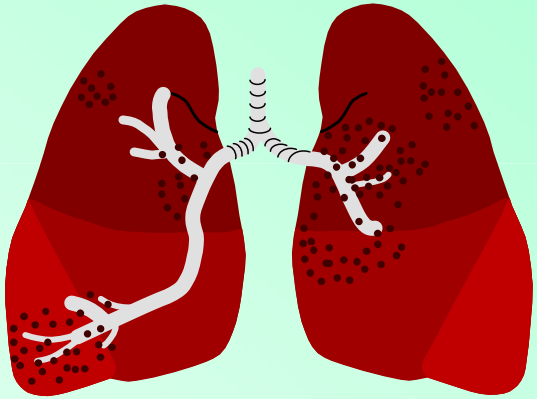
Le bilan vital

La fonction nerveuse (cerveau)



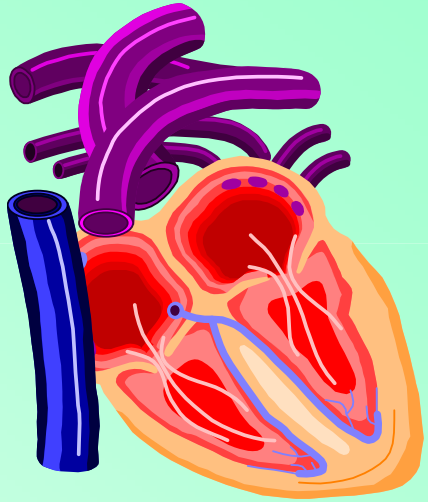
CONSCIENCE

La fonction ventilatoire (poumons)

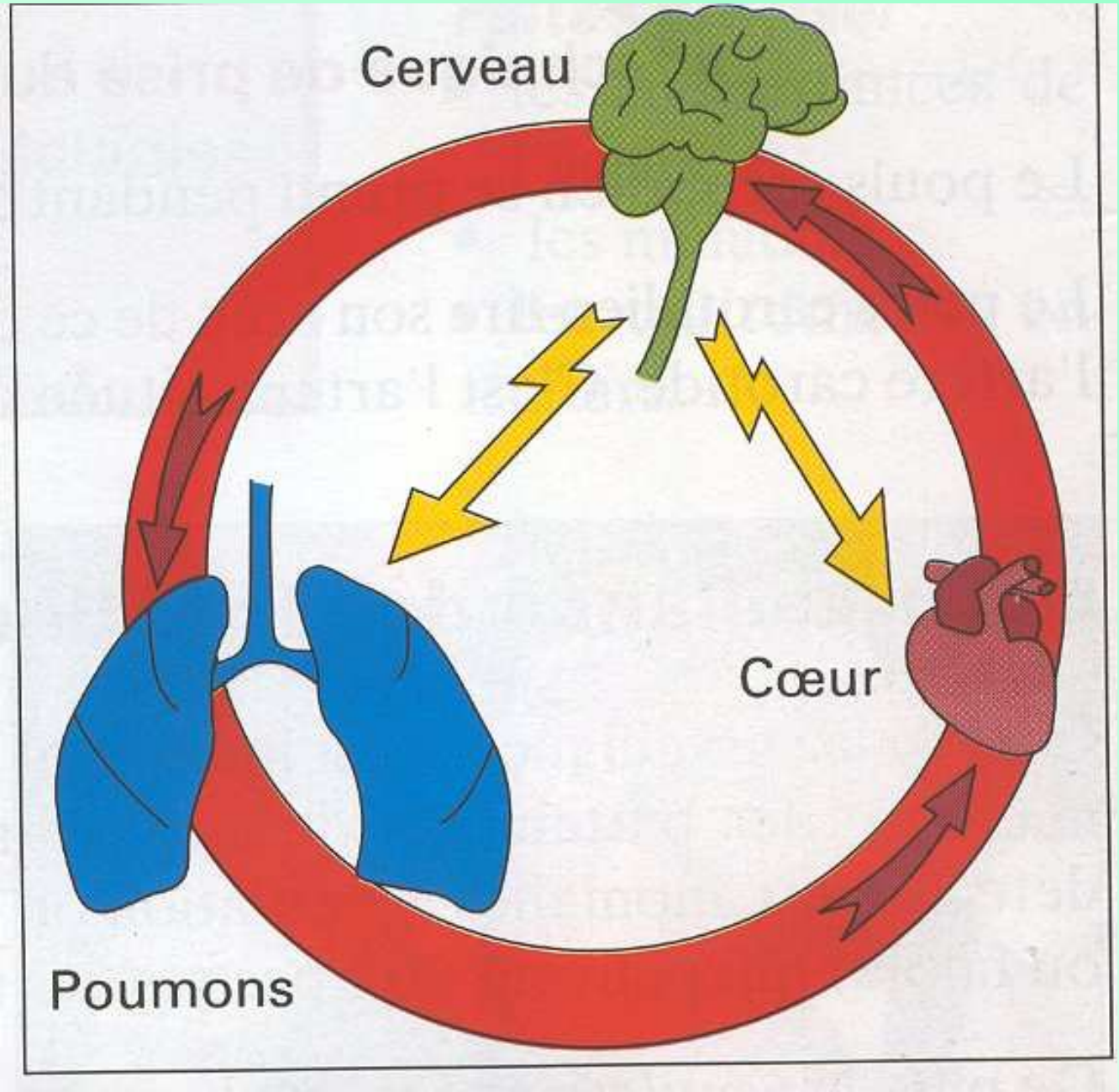


RESPIRATION

La fonction circulatoire (coeur)

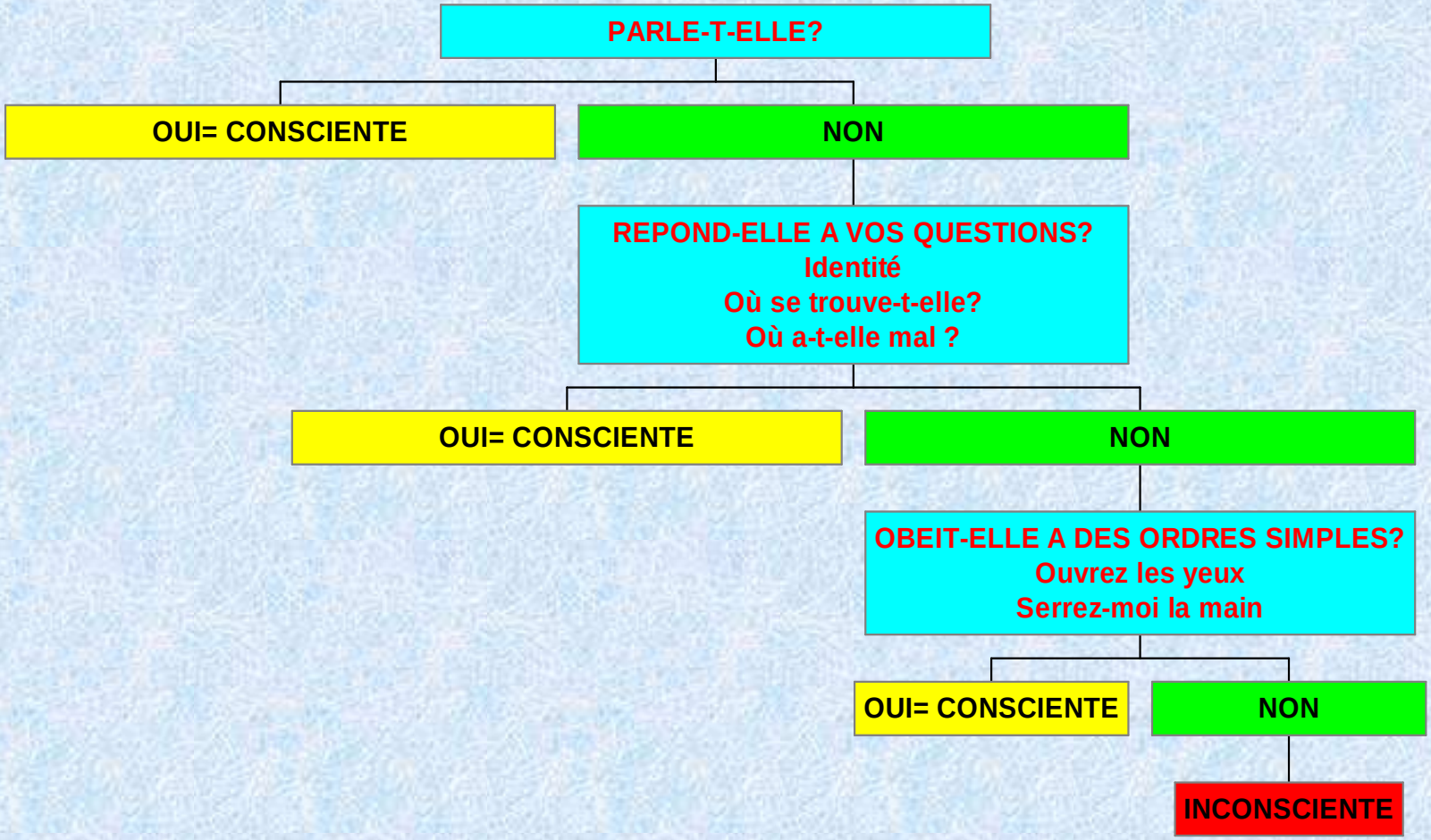


CIRCULATION

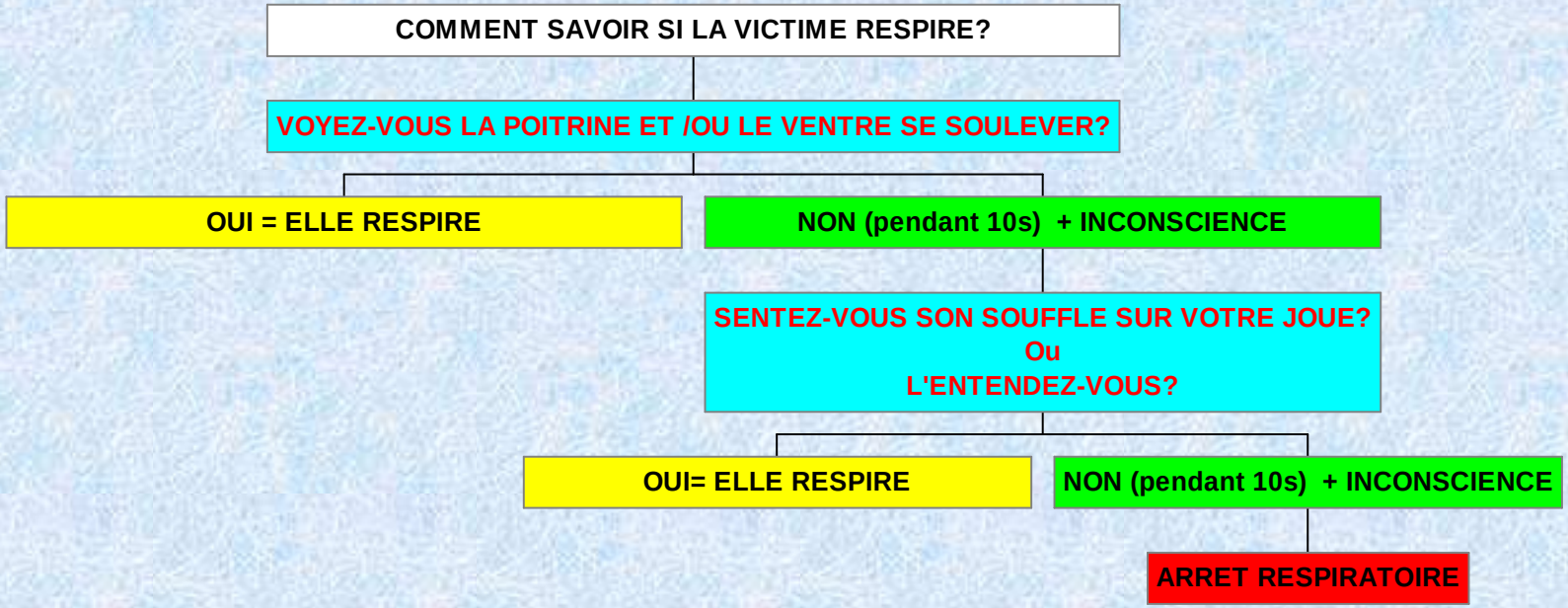

Cerveau
Cœur
Poumons

Bilan de la CONSCIENCE
(fonction du cerveau)

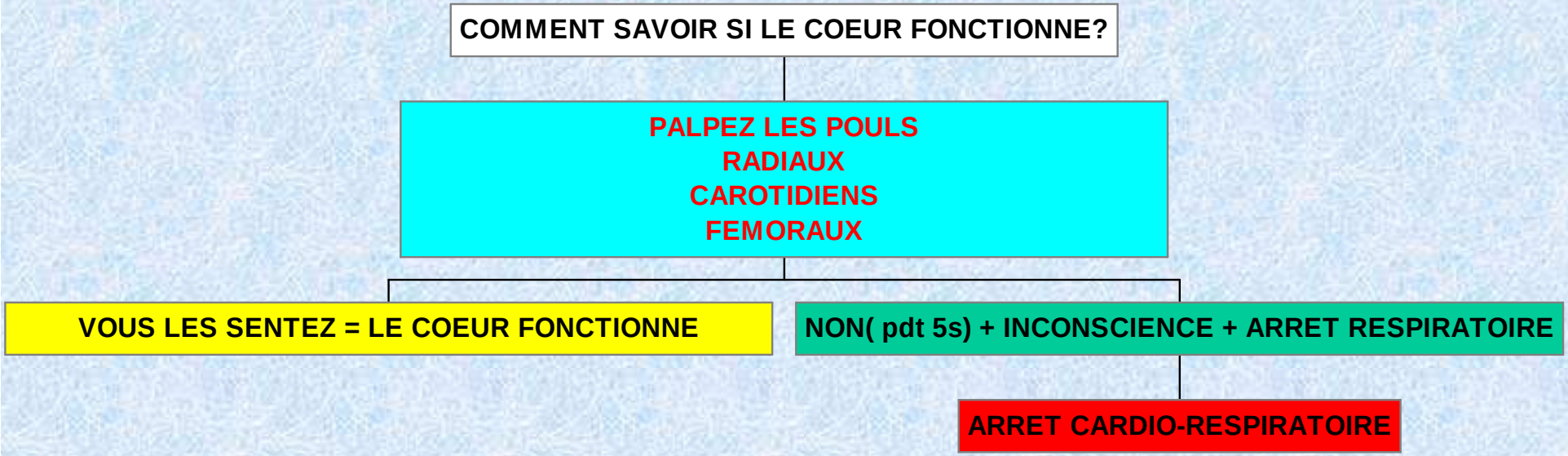
LA VICTIME



Bilan de la RESPIRATION
(Poumons)



Bilan de la CIRCULATION
(cœur)



AGIR

1. Cas de l ’INCONSCIENCE
2. Cas de l ’ARRET RESPIRATOIRE
3. Cas de l ’ARRET CARDIO-RESPIRATOIRE

1. Cas de l ’INCONSCIENCE

La victime

- ne parle pas
- ne répond pas à vos questions
- n ’obéit pas aux ordres simples
- respire
- Vous sentez les pouls

ELLE RISQUE DE MOURIR PAR ETOUFFEMENT
SI VOUS N ’AGISSEZ PAS

Que faire devant une victime inconsciente ?

1. Libérer les voies aériennes
2. Mettre en position latérale de sécurité
3. Alerter les secours

1- Libérez les voies aériennes

- Desserrer col et ceinture
- Nettoyer et enlever tout corps étranger de la bouche
- Basculer la tête en arrière
- Vérifier que la victime respire

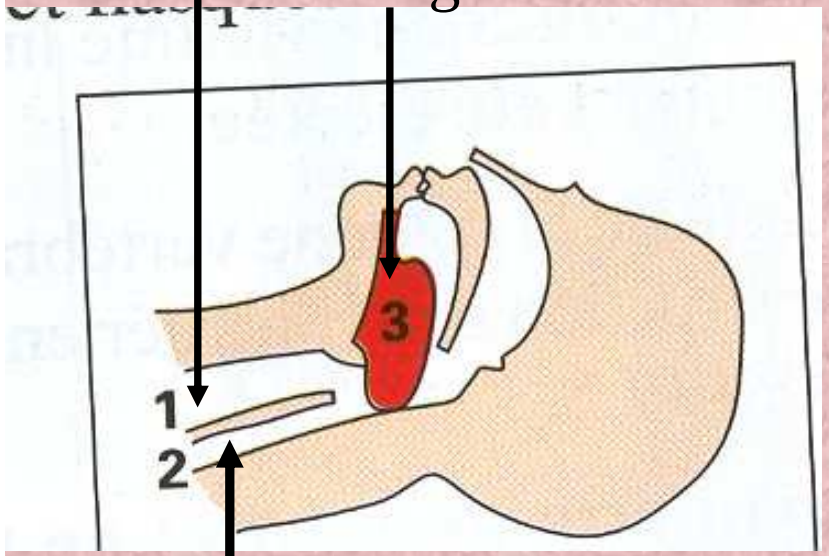
Nettoyer la bouche

1.Nettoyer la bouche avec 2 doigts et retirer les corps étrangers (appareils ou prothèsesdentaires , aliments)

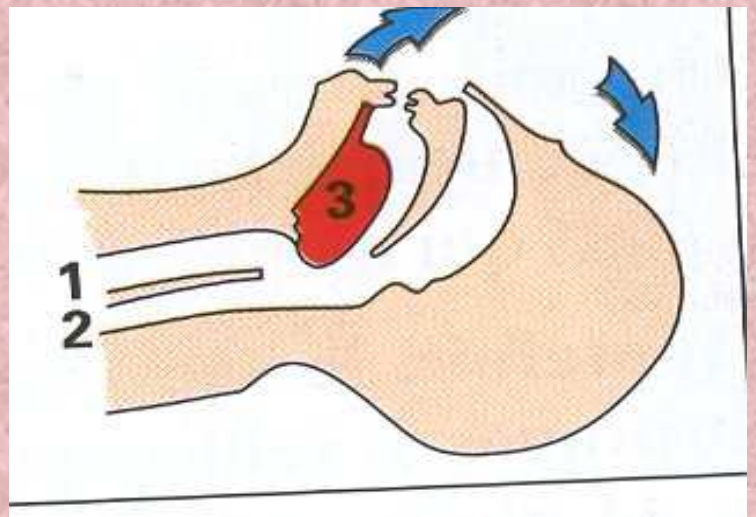
2.Retirer les liquides en s ’aidant d ’un tissu propre au besoin (mouchoir)

Tube digestif

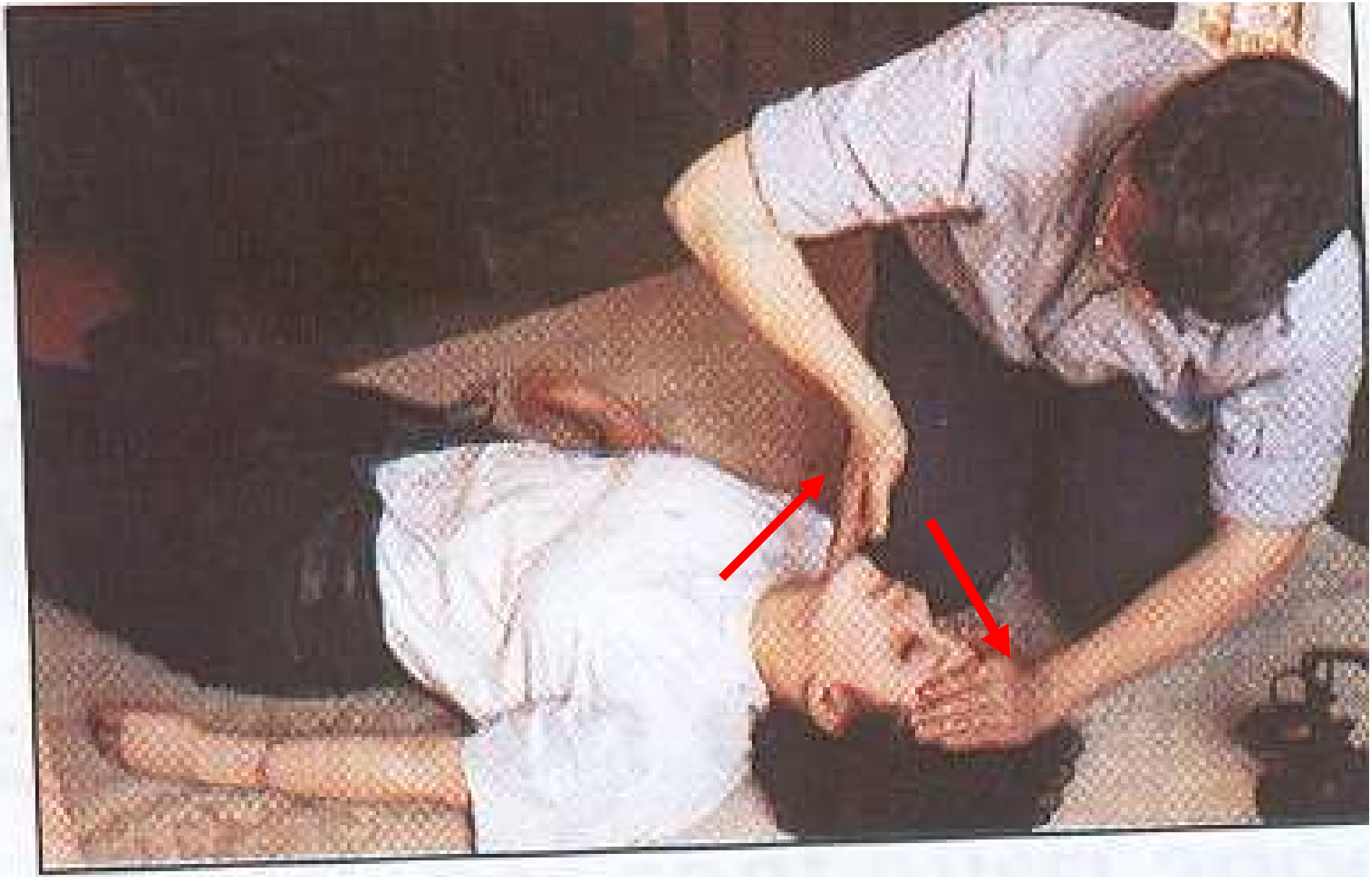
Langue



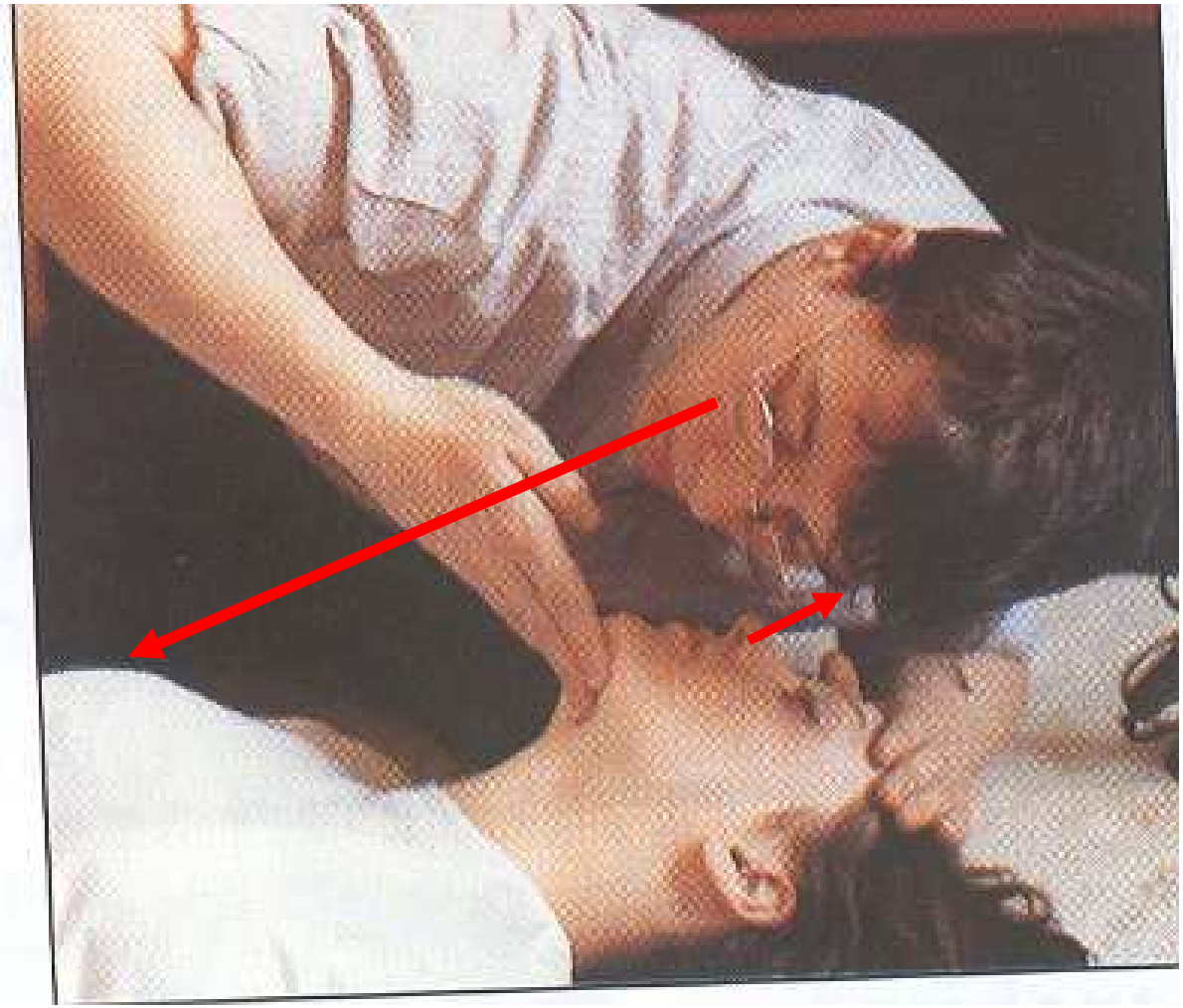
Trachée



Basculer la tête en arrière



Vérifier que la victime respire



2 . METTRE LA VICTIME EN POSITION LATERALE DE SECURITE ou PLS

- Mettre la victime sur le côté
- Basculer à nouveau la tête en arrière

La position latérale de sécurité (PLS)

3. Alerter les secours

Sapeurs pompiers : 18

Police Secours : 17

HJRA: 22 279 79

HOMI: 22 403 41

Espace Médical : 22 625 66

Ambulance municipale : 22 200 40

AU TOTAL

VICTIME INCONSCIENTE

1. **Libérer les voies aériennes**
2. **Mettre en PLS**
3. **Alerter les secours**

2. Cas de l ’arrêt respiratoire

La victime

- est inconsciente
- ne respire pas

PENDANT 10s

- vous ne voyez pas la poitrine ou le ventre se soulever pendant
- vous ne sentez ,ni n ’entendez son souffle sur votre joue

- Vous sentez ses pouls

Que faire devant une victime en arrêt respiratoire?

1 - Libérer les voies aériennes

2 - Alerter ou faire alerter les secours

3- Pratiquer le bouche-à-bouche

1- Libérez les voies aériennes

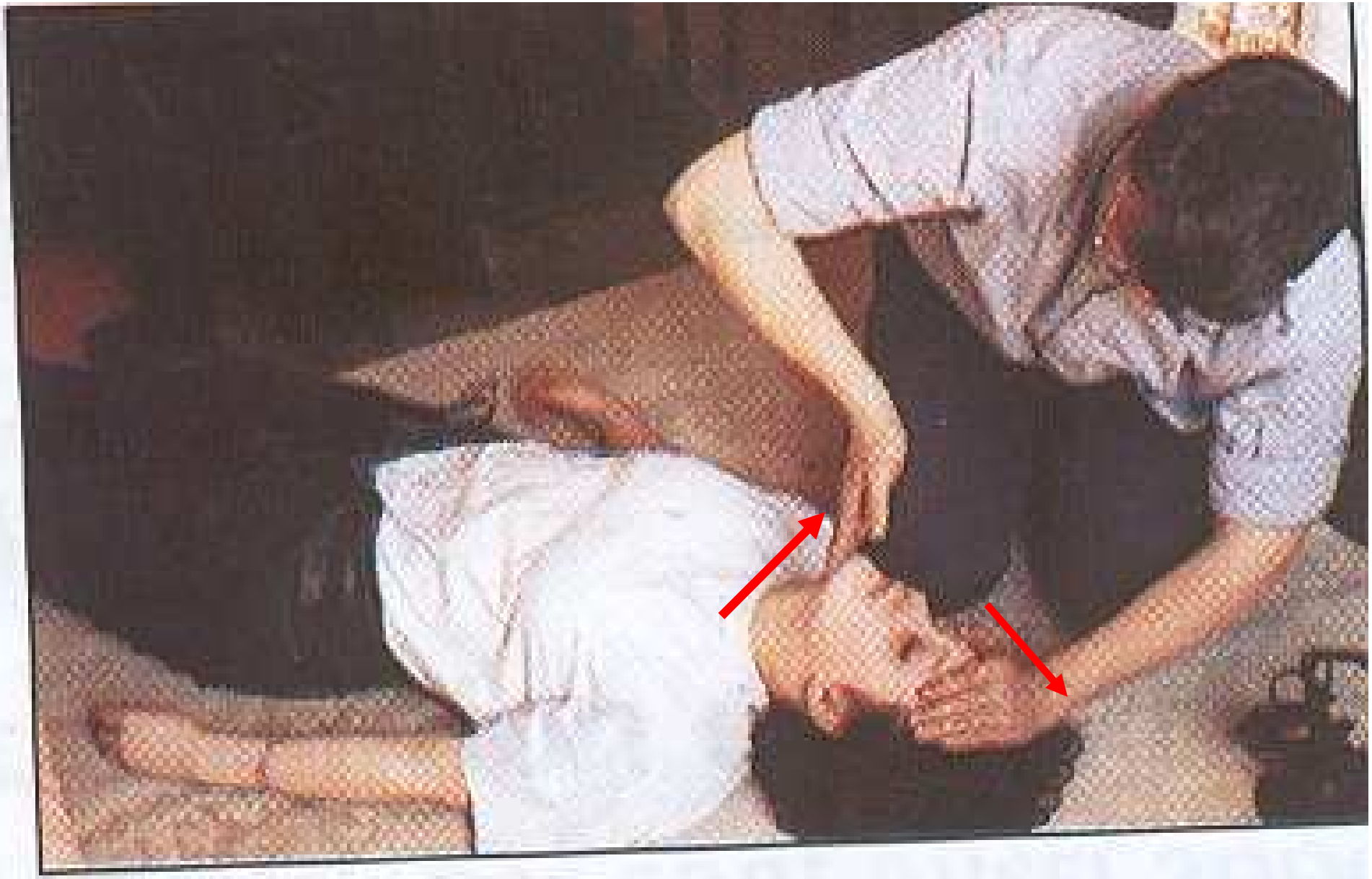
- Desserrer col et ceinture
- Nettoyer et enlever tout corps étranger de la bouche
- Basculer la tête en arrière

Nettoyer la bouche

1.Nettoyer la bouche avec 2 doigts et retirer les corps étrangers (appareils ou prothèsesdentaires , aliments)

2.Retirer les liquides en s ’aidant d ’un tissu propre au besoin (mouchoir)

Basculer la tête en arrière



2. Alerter ou faire alerter les secours

Sapeurs pompiers : 18

Police Secours : 17

HJRA: 22 279 79

HOMI: 22 403 41

Espace Médical : 22 625 66

Ambulance municipale : 22 200 40

3. Pratiquer le bouche-à- bouche

1. Gardez la tête de la victime en arrière.

Avec trois doigts, maintenez le menton tiré en haut et en avant.

2. Pincez les narines de la victime entre le pouce et l'index.

3. Plaquez largement votre bouche autour de celle de la victime.

Soufflez progressivement pendant 1 à 2 secondes.

4. La poitrine et le ventre se soulèvent.

5. Gardez la tête basculée en arrière.

Maintenez le menton tiré en haut et en avant.

Relâchez les narines.

6. Redressez-vous complètement.

Regardez la poitrine et le ventre s'abaisser.

Inspirez et recommencez une insufflation.

AU TOTAL

Victime en arrêt respiratoire

1 - Libérer les voies aériennes

2 - Faire alerter les secours

3 -Pratiquer le bouche-à-bouche

3. Cas de l ’arrêt cardio-respiratoire

La victime

- est inconsciente
- elle ne respire pas
- Vous ne sentez pas les pouls pendant 5s

1er maillon + rapide = Chance de survie victime augmente de 50%

L ’absence d ’O2 entraîne des dégâts irréversibles en 3 minutes et peut entraîner la mort

Que faire devant une victime en arrêt cardio-respiratoire ?

1- Libérer les voies aériennes

2-Alerter ou faire alerter les secours

3-4 - Pratiquer le massage cardiaque externe

le bouche-à-bouche

1- Libérez les voies aériennes

- Desserrer col et ceinture
- Enlever tout corps étranger de la bouche
- Basculer la tête en arrière

2. Alerter les secours

Sapeurs pompiers : 18

Police Secours : 17

HJRA: 22 279 79

HOMI: 22 403 41

Espace Médical : 22 625 66

Ambulance municipale : 22 200 40

3/4. Pratiquez MCE et BàB

Si vous êtes seul :

- Faire 15 MCE + 2 insufflations + 15MCE + 2 insufflations + 15 MCE …..

Si vous êtes 2 sauveteurs :

- Faire 5 MCE (1er sauveteur) + 2 insufflations

(2ème sauveteur) + 5 MCE + 2 insufflations…

-En une minute 60 MCE et 8 insufflations

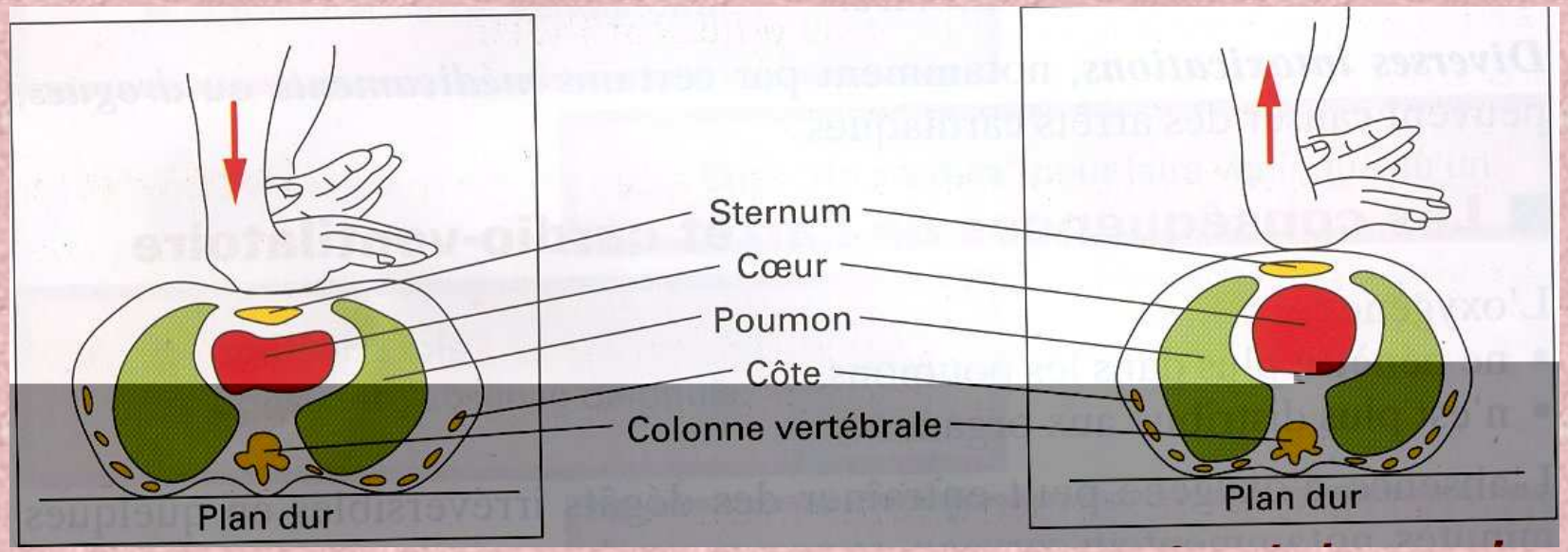
-Surveillez le pouls toutes les 2 minutes , si le pouls est absent , continuez MCE + BàB , s ’il est présent continuez le BàB.

PRINCIPE et TECHNIQUE DU MCE

TOUJOURS SUR UN PLAN DUR

Augmenter la pression de l 'ensemble du thorax pour expulser le sang du cœur vers les vaisseaux

Diminuer la pression de l 'ensemble du thorax , le cœur se remplit de sang et reprend sa forme initoale



PLAN DUR

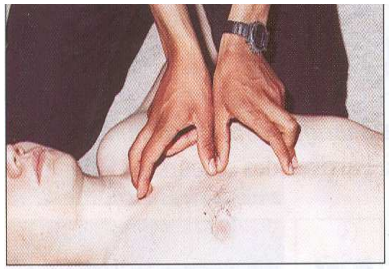
COMPRESSION

RELACHEMENT

LA TECHNIQUE DU MCE

1. Le bras de la victime fait un angle droit avec son corps vous vous mettez à cheval sur son bras , vos genoux contre son corps

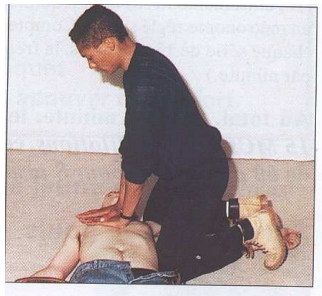
2.Repérez avec les majeurs les extrêmités du sternum



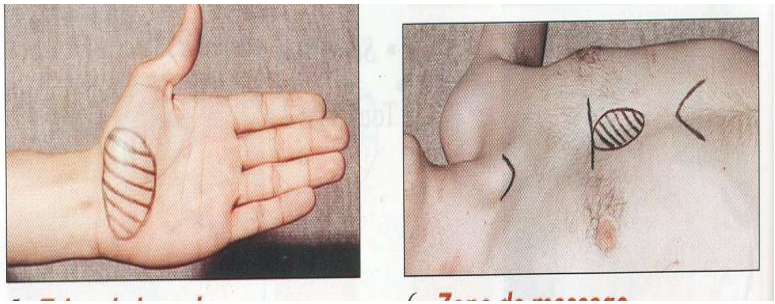
3.Divisez le sternum en 2 parties égales

4.Placez le talon de la main située près du ventre contre le pouce de l ’autre main

5. Placez la seconde main sur la première , relever les doigts



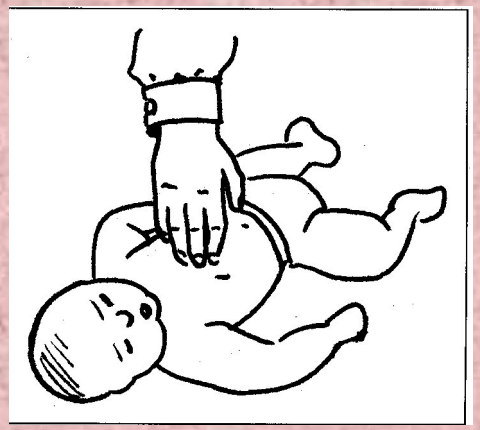
6. Les bras tendus verticalement , appuyez de 3 à 4 cm , puis relâcher totalement sans déplacer ni enlever les mains (temps d ’appui = temps de relâchement)



Le talon de la main et la zone de massage

Cas particuliers : MCE chez l ’enfant et le nourrisson

MCE PLUS RAPIDES et MOINS FORTS



1main - 100 / minute

3 doigts - 120 / minute

15 MCE + 2 Insufflations

AU TOTAL

VICTIME EN ARRET CARDIO-RESPIRATOIRE

1. Libérer les voies aériennes

2.Alerter ou faire alerter les secours

3.4. Pratiquer les MCE et le bouche-à-bouche

Cas particulier de l ’hémorragie

La victime perd beaucoup de sang

Le sang apporte l ’oxygène à tout l ’organisme

Si l ’hémorragie n ’est pas arrêtée , elle peut mettre la vie en danger

Que faire devant une hémorragie?

- Protéger (écarter le danger)
- Appuyer
- Allonger
- Alerter ou faire alerter les secours
- Surveiller , couvrir et réconforter

APPUYER

1. La compression locale
2. La compression à distance
3. Le garrot
4. Cas particuliers : hémorragie par des orifices naturels : nez - bouche

1. La compression locale

La compression locale manuelle

(avec le main)

Le pansement compressif

La compression locale manuelle
quand vous n ’êtes pas le seul sauveteur

Danger : Couteau

Ecarter le couteau

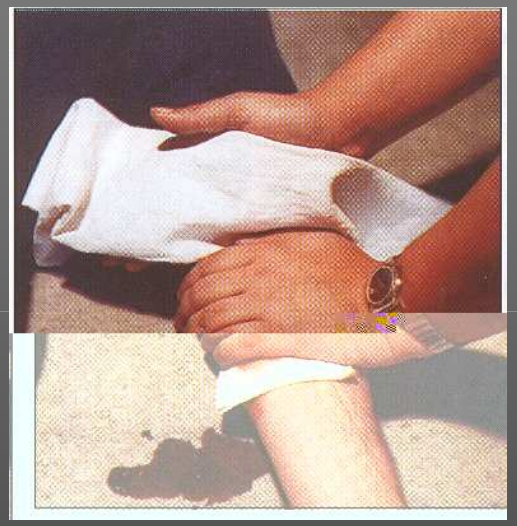
Appuyer avec la paume de la main et allonger

Faire alerter les secours ,surveiller conscience , ventilation , pouls , couvrir

Le pansement compressif
Quand vous êtes le seul sauveteur

Danger : la scie électrique

Débrancher et écarter



Appuyer avec la paume de la main

Allonger , mettre le pansement (linge propre et attacher avec un lien large)

Alerter les secours

Surveiller : conscience , ventilation ,pouls

Couvrir

2.La compression à distance

quand la compression locale est impossible

Compression à distance
Membre supérieur

Danger : les morceaux

de verre sur le sol

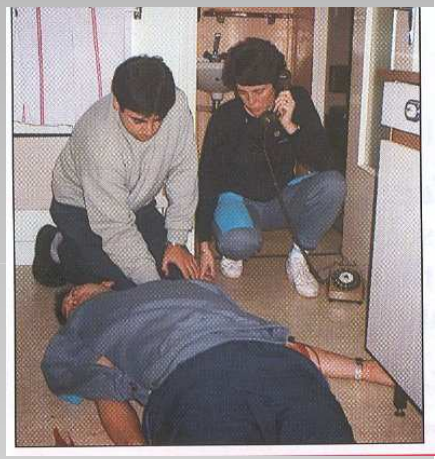
Ramasser et jeter

Appuyer ,

CL impossible

(verres) , donc CAD

Pouce derrière le clavicule , appuyer en direction du pied opposé



Faire alerter les secours

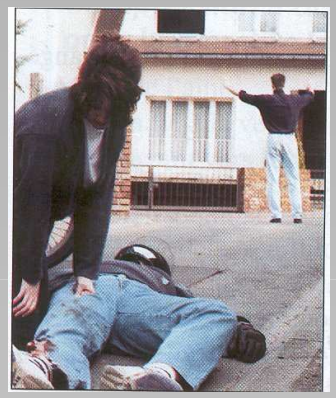
Surveiller et couvrir et réconforter

Compression à distance
Membre inférieur

Danger : le moteur de la moto qui tourne circulation

Protéger

Faire couper le contact , arrêter la circulation



Os apparent , CL impossible

donc CAD

Allonger

CAD au pli de l ’aine , avec le poing , bras tendu et vertical

Faire alerter les secours

Surveiller , couvrir et réconforter

Compression à distance
Au niveau du cou

Danger : le rasoir

Ecarter

Appuyer

CL impossible

(étouffement)

donc CAD

Allonger

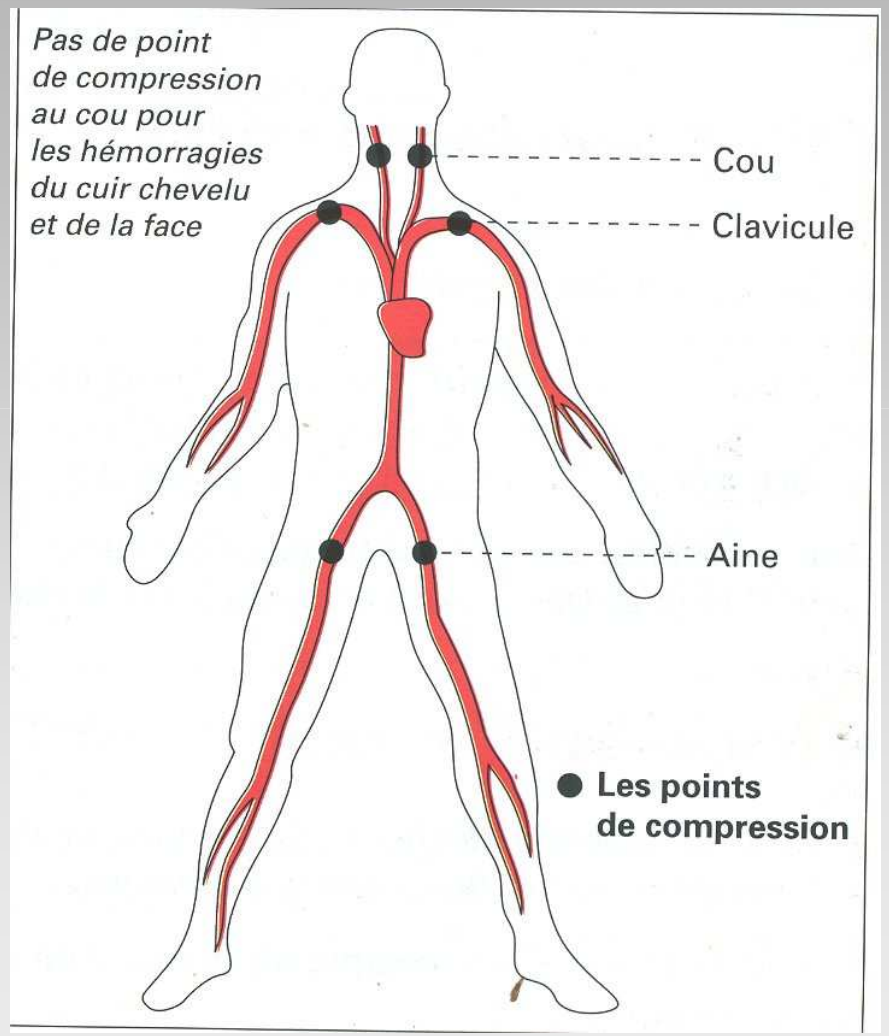
CAD : à la base du cou , pouce à l ’endroit du pouls carotidien , main en pince pouce appuie vers l ’intérieur

Faire alerter les secours

Surveiller , couvrir et réconforter

La compression à distance

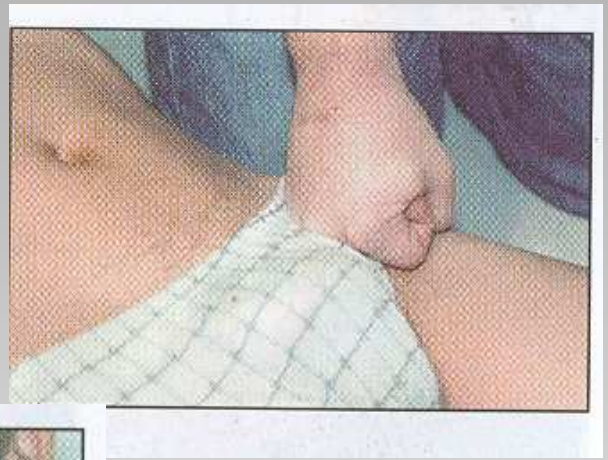
Les points de compression



La compression à distance

Les points de compression

Membre supérieur



Membre supérieur

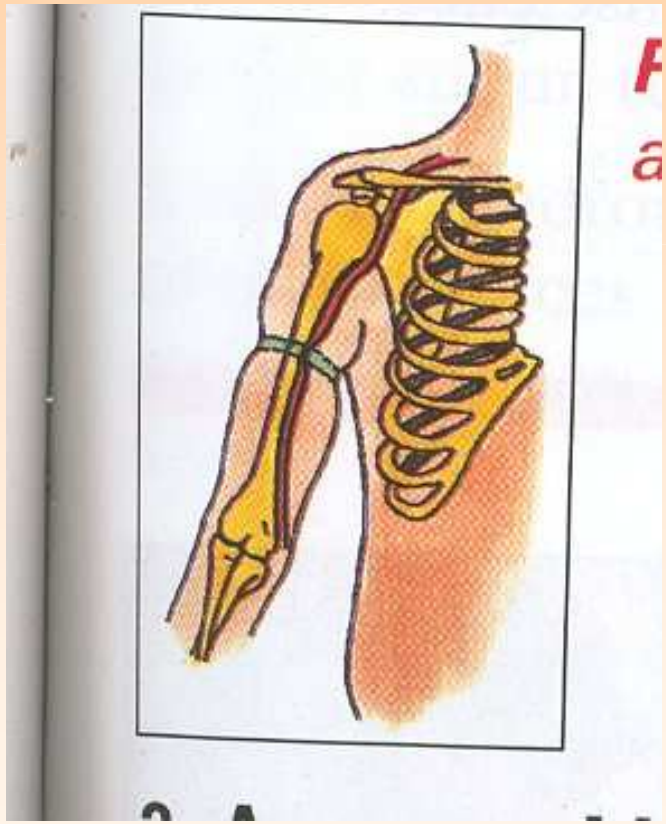
Au niveau du cou

Poing ou pouce droit quand ça saigne à gauche

Poing ou pouce gauche quand ça saigne à droite

3.Le garrot

Quand la compression locale et la compression à distance sont impossibles ou inefficaces(délabrement d ’un membre, surface étendue de blessure , plusieurs victimes)



Membre supérieur

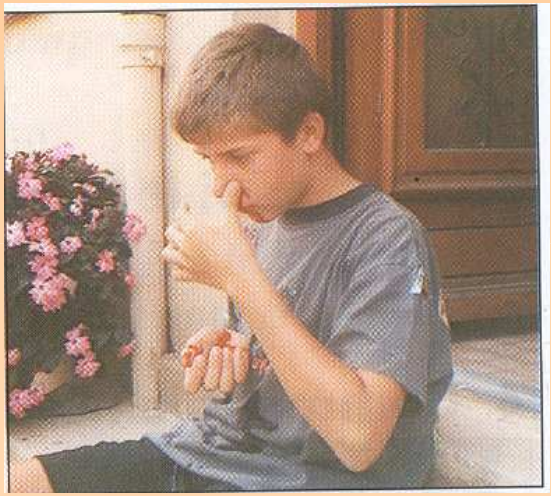
Membre inférieur

La technique de la pose du garrot

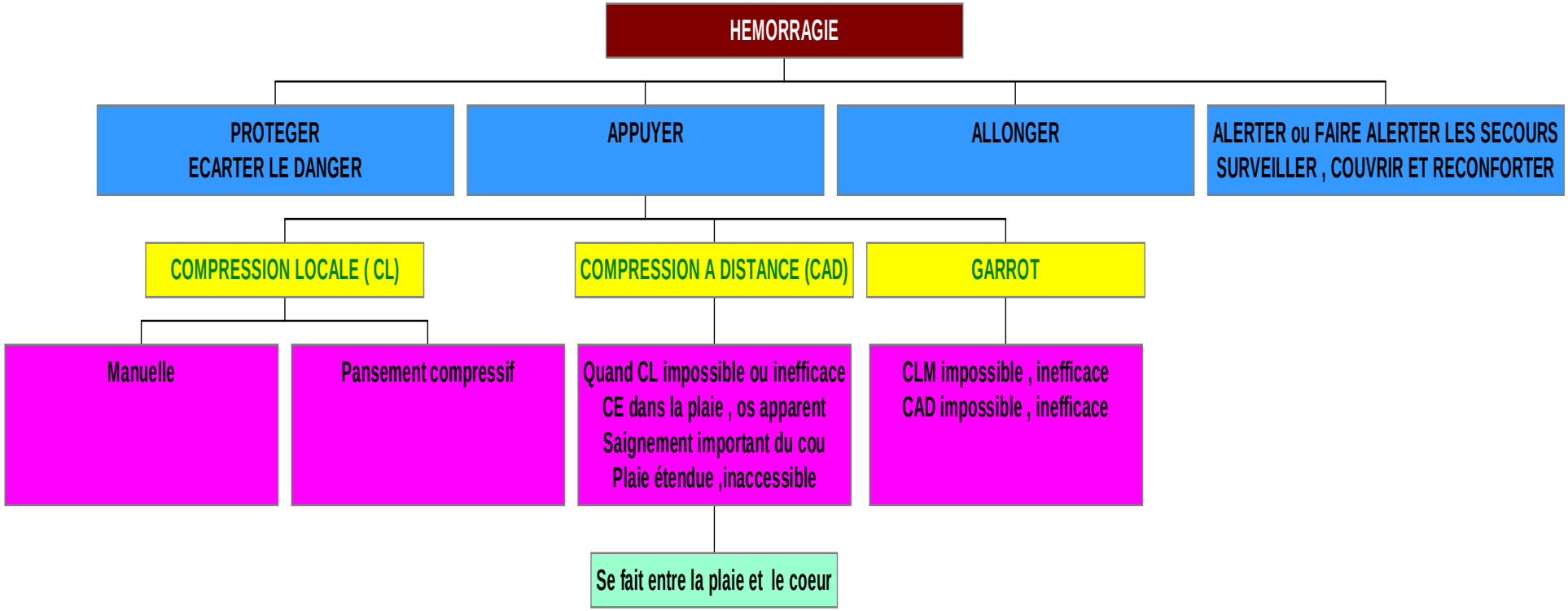
Avec un lien large

4.Hémorragie par des orifices naturels

HEMORRAGIE PAR LA BOUCHE



HEMORRAGIE PAR LE NEZ


HEMORRAGIE
PROTEGER
ECARTER LE DANGER
APPUYER
ALLONGER
ALERTER ou FAIRE ALERTER LES SECOURS
SURVEILLER , COUVRIR ET RECONFORTER
COMPRESSION LOCALE (CL)
COMPRESSION A DISTANCE (CAD)
GARROT
Manuelle
Pansement compressif
Quand CL impossible ou inefficace
CE dans la plaie , os apparent
Saignement important du cou
Plaie étendue ,inaccessible
CLM impossible , inefficace
CAD impossible , inefficace
Se fait entre la plaie et le coeur

CONCEPTION :

Chef Enoch
A.M.A.F ANDOHATAPENAKA
Distrika Isotry Tsaralalàna
Grande Zone 11

033.13.972.17
034.19.589.59